

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

OPINIA PRZEDSZKOLA / SZKOŁY · DLA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO · DLA RODZICA

OCENA FUNKCJONALNA · ICF · PRZEDSZKOLE · SZKOŁA

Raport Oceny Funkcjonalnej

OBSERWACJA WSTĘPNA I POGŁĘBIONA · OBSZARY ICF

z dnia _____

OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ W SKŁADZIE

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 4. _____ |
| 5. _____ | 6. _____ |

§

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (**Dz. U. z 2026 r. poz. 428**), a w szczególności wchodzącymi w życie z dniem 1 września 2026 r. przepisami **§ 7 ust. 6 i ust. 7**, opinia przedszkola/szkoły wydawana dla zespołu poradni (i przekazywana rodzicowi) musi mieć ściśle określoną strukturę opartą na obszarach ICF: odrębnych dla dziecka w wieku przedszkolnym oraz dla ucznia szkoły.

■ CZĘŚĆ I · PODSTAWA, METRYCZKA I NARZĘDZIA

1

Metryczka bazowa

dane dziecka, wariant wsparcia, podstawa formalna, zdrowie i farmakoterapia

2

Obserwacja wstępna

procedura wrześniowej obserwacji
Kwestionariuszem Oceny Funkcjonalnej w obszarach ICF

3

Obserwacja pogłębiona

wskazania i narzędzia: ABC, Profil Biopsychospołeczny, Profil Sensoryczny, mowa i AAC, ToM

■ CZĘŚĆ II · WYNIKI ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE, OCENA POGŁĘBIONA, KIERUNKI WSPARCIA W IPE, ZALECENIA PORADNI

4

Funkcjonowanie w placówce

mocne strony, uzdolnienia i trudności

5

Wyniki liczbowe

KPOF / KSzOF
w 9 domenach ICF

6

Analiza jakościowa

opis barier i zalecenia do IPE

7

Obserwacja pogłębiona

wyniki arkuszy specjalistycznych

8

Podjęte działania

zakres wsparcia i efektywność

9

Zalecenia poradni

rewalidacja · PPP · sposoby realizacji

ICF

KSzOF

ABC

Profil Sensoryczny

AAC

ToM

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

1 METRYCZKA BAZOWA

IMIĘ I NAZWISKO	[Imię i Nazwisko dziecka / ucznia]
DATA URODZENIA	[Data urodzenia]
PLACÓWKA / ODDZIAŁ	[Nazwa przedszkola / szkoły, grupa / klasa]
WARIANT WSPARCIA	☐ Wariant A – wsparcie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ☐ Wariant B – wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (bez orzeczenia)
JEDNOSTKA / PODSTAWA FORMALNA	Na podstawie dołączonego dokumentu: [Orzeczenie / Opinia] nr [Numer] z dnia [Data], wydanego przez: [Nazwa Poradni], z uwagi na: [np. autyzm, w tym zespół Aspergera / niepełnosprawność ruchowa / inne]
SCHOROZENIA PRZEWLEKŁE	☐ Brak ☐ Występują: [np. cukrzyca, astma, epilepsja]
FARMAKOTERAPIA I WSKAZANIA LEKARZA	Zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecko/uczeń stale / doraźnie przyjmuje leki: [Nazwa leków, zalecenia postępowania / Nie dotyczy]

2 PODSTAWA I PROCEDURA OBSERWACJI WSTĘPNEJ

1 Zgłoszenie zgłaszane trudności w funkcjonowaniu oraz wniosek rodzica	2 Dokumentacja posiadana opinia / orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej	3 Obserwacja · wrzesień Kwestionariusz Przedszkolnej / Szkolnej Oceny Funkcjonalnej	4 Analiza ICF obszary zgodne z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania
--	---	---	---

Z uwagi na zgłaszane trudności w funkcjonowaniu, wniosek rodzica oraz posiadaną dokumentację (w tym opinię/orzeczenie poradni), w placówce przeprowadzono **we wrześniu** obserwację poziomu funkcjonowania z wykorzystaniem **Kwestionariusza Przedszkolnej / Szkolnej Oceny Funkcjonalnej**, analizującego funkcjonowanie w obszarach zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Funkcje ciała
bStruktury ciała
sAktywność i
uczestnictwo
dCzynniki środowiskowe
eCzynniki osobowe
—

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

3 WSKAZANIA DO OBSERWACJI POGŁĘBIONEJ I ZASTOSOWANE NARZĘDZIA

W związku ze zidentyfikowanymi w toku oceny wstępnej trudnościami w funkcjonowaniu – w szczególności w zakresie **trudnych zachowań**, **rozwoju funkcji poznawczych**, **przetwarzania bodźców** oraz **komunikacji** – przeprowadzono obserwację pogłębioną z wykorzystaniem następujących narzędzi specjalistycznych:

ZACHOWANIA TRUDNE

Arkusze Obserwacji Behawioralnej ABC

Zastosowany z uwagi na występowanie zachowań trudnych – identyfikacja bodźców wywołujących, formy zachowania oraz funkcji i skutków podtrzymujących.

A

bodźce wywołujące

B

forma zachowania

C

funkcja i skutki podtrzymujące

CAŁOŚCIOWY OBRAZ

Profil Biopsychospołeczny

Ujęcie funkcjonowania dziecka w wymiarze biologicznym, psychologicznym i społecznym – zgodnie z modelem ICF.

PRZETWARZANIE BODŹCÓW

Profil Sensoryczny

Ocena reaktywności sensorycznej (nadwrażliwości, podwrażliwości, poszukiwania stymulacji) i wpływu bodźców środowiskowych na dysregulację dziecka.

KOMUNIKACJA

Arkusze Oceny Rozwoju Mowy i Komunikacji

Zastosowany w związku ze specyficznymi trudnościami w nadawaniu i rozumieniu mowy, echolaliami lub potrzebą wdrożenia / rozwijania AAC.

FUNKCJE POZNAWCZE I SPOŁECZNE

Arkusze Poziomu Rozwoju Teorii Umysłu (ToM)

Zbadanie poziomu rozumienia stanów mentalnych, intencji, perspektywy i emocji innych osób w sytuacjach społecznych.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

RAPORT OCENY FUNKCJONALNEJ DZIECKA / UCZNIA · CZĘŚĆ II

Wyniki ilościowe i jakościowe, ocena pogłębiona oraz kierunki wsparcia w IPE

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH ARKUSZY OBSERWACJI · § 7 UST. 6

4 INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU W PLACÓWCE – TRUDNOŚCI, MOCNE STRONY I UZDOLNIENIA

§ 7 ust. 6 pkt 3. Syntetyczne zestawienie potencjału rozwojowego oraz barier zidentyfikowanych w toku codziennej aktywności przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/ucznem:

OBSZAR OBSERWACJI	✓ MOCNE STRONY, ZASOBY I UZDOLNIENIA	► TRUDNOŚCI, OGRANICZENIA I BARIERY
Aktywność poznawcza i uczenie się	Bardzo dobra pamięć wzrokowa; szybkie zapamiętywanie schematów graficznych; wąskie, ale głębokie zainteresowania tematyczne; wysoka motywacja do pracy z ulubionymi pomocami dydaktycznymi.	Trudności z przerzutnością i podzielnością uwagi; szybka męczliwość przy instrukcjach wieloetapowych; problem z uogólnianiem (generalizacją) wiedzy; wymagane stałe tempo i pomoce wizualne.
Komunikacja i porozumiewanie się	Prawidłowe rozumienie prostych, jednoznacznych komunikatów słownych wspartych gestem; sygnalizowanie podstawowych potrzeb fizjologicznych.	Dosłowne rozumienie wypowiedzi (trudność z metaforą i żartem); echolalie odroczone; trudności w inicjowaniu dialogu i naprzemienności wypowiedzi w grupie rówieśniczej; potrzeba wsparcia AAC.
Relacje społeczne i emocje	Chęć przebywania w pobliżu grupy; pozytywna reakcja na stałych, przewidywalnych dorosłych; przestrzeganie czytelnych zasad wizualnych.	Trudności w odczytywaniu emocji i intencji innych (słaba teoria umysłu); niska tolerancja frustracji w sytuacjach przegranej lub nagłej zmiany; tendencja do wycofywania się lub zachowań trudnych.
Motoryka i sprawność fizyczna	Sprawność w zakresie motoryki dużej (bieganie, wspinanie się); chętnie uczestnictwo w zabawach ruchowych w otwartej przestrzeni.	Obniżona precyzja motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; nieprawidłowy chwyt pisarski / narzędzi; wzmożone lub obniżone napięcie posturalne; męczliwość ręki wiodącej.
Samoobsługa i autonomia	Samodzielność w zakresie podstawowych nawyków higienicznych i toaletowych; znajomość własnej szafki i osobistych przyborów.	Opór sensoryczny przy myciu rąk (wrażliwość na fakturę mydła/wodę); wybiórczość pokarmowa; problem z ubieraniem odzieży wierzchniej ze skomplikowanymi zapięciami; potrzeba nadzoru dorosłego.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

5 AKTUALNA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA – WYNIKI LICZBOWE

§ 7 ust. 6 pkt 4. Zestawienie parametrów ilościowych uzyskanych z narzędzia bazowego (KPOF dla przedszkola / KSzOF dla szkoły) w 9 obszarach Międzynarodowej Klasyfikacji ICF:

NARZĘDZIE BAZOWE

☐ Przedszkole · KPOF · bez stenów☒ Szkoła · KSzOF · ze stenami

NARZĘDZIE BAZOWE

KSzOF szkoła

PUNKTY SUROWE

68 / 180 pkt

ŚREDNIA

Śr: 2,1 w skali 0–5

OGÓLNY POZIOM WSPARCIA

Poziom 2

(Umiarkowany)

KOD	DOMENA ICF	PUNKTY / ŚR.	STEN (KSZOF)	POZIOM WSPARCIA	WSKAŹNIK FUNKCJONALNY
d1	Uczenie się i stosowanie wiedzy	Śr: 2,4 (12 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Wymaga podziału zadań na etapy i wsparcia wizualnego.
d2	Ogólne zadania i wymagania	Śr: 1,8 (9 pkt)	Sten 3	Poziom 3 · Wysoki	Brak elastyczności, silny stres przy nagłych zmianach.
d3	Komunikacja i porozumiewanie się	Śr: 2,0 (10 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Echolalie, konieczność wdrażania schematów AAC.
d4	Poruszanie się i motoryka	Śr: 3,2 (16 pkt)	Sten 6	Poziom 1 · Niski	Ogólna motoryka dobra; obniżona grafomotoryka.
d5	Dbanie o siebie i samoobsługa	Śr: 2,2 (11 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Wybiórczość sensoryczna przy posiłkach i toalecie.
d6	Życie domowe / Obowiązki placówki	Śr: 2,8 (14 pkt)	Sten 5	Poziom 1 · Niski	Sprząta kącik zabaw po bezpośrednim przypomnieniu.
d7	Relacje i kontakty międzyludzkie	Śr: 1,6 (8 pkt)	Sten 3	Poziom 3 · Wysoki	Bariery w interakcjach rówieśniczych, konflikty, wycofanie.
d8	Główne dziedziny życia (Edukacja)	Śr: 2,0 (10 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Wymaga dostosowania metod i stałego nadzoru nauczyciela.
d9	Życie społecznościowe i obywatelskie	Śr: 1,8 (9 pkt)	Sten 3	Poziom 3 · Wysoki	Trudność w uczestnictwie w apelach i wyjściach zbiorowych.

Pasek: Średnia w skali 0–5

Poziom 1 · Niski

Poziom 2 · Średni

Poziom 3 · Wysoki

Zasada: wybrano **KSzOF (szkoła)** – steny podaje się wyłącznie w kolumnie „Sten” dla poszczególnych domen; średniej nigdy nie opisuje się stenem.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

6 ANALIZA JAKOŚCIOWA OBSZARÓW OBSERWACJI ORAZ ZALECENIA DO IPE

Szczegółowa diagnoza funkcjonalna we wszystkich **9 domenach ICF**, powiązana bezpośrednio ze sformułowanymi rekomendacjami do **Indywidualnego Programu Edukacyjnego (IPE)**:

DOMENA ICF	OPIS FUNKCJONOWANIA I BARIERY	ZALECENIA DO IPE (METODY / DOSTOSOWANIA)
Uczenie się i stosowanie wiedzy d1	Dziecko/uczeń przyswaja wiedzę głównie kanałem wzrokowym. Występuje trudność w rozumieniu poleceń złożonych oraz w transferze (uogólnianiu) wiedzy. Przebodźcowanie powoduje dekoncentrację i rezygnację z zadania.	- Plany aktywności w formie piktogramów / checklist. - Dzielenie instrukcji na pojedyncze, sekwencyjne kroki. - Wydłużenie czasu na realizację zadań pisemnych i wykonawczych.
Ogólne zadania i wymagania d2	Trudność w samodzielnej organizacji pracy i realizacji zadań wieloetapowych. Brak elastyczności – silny stres przy nagłych zmianach planu i przejściach między aktywnościami.	- Stały, wizualny plan dnia i zapowiadanie zmian z wyprzedzeniem. - Pomoce sensoryczne do orientacji w czasie (stoper, zegar time-timer). - Protokół wyprzedzający przed trudnymi przejściami.
Komunikacja i porozumiewanie się d3	Wypowiedzi cechują się trudnościami pragmatycznymi, obecnością echolalii oraz dosłownością interpretacji. W chwilach przeciążenia emocjonalnego następuje mutyzm wybiórczy lub krzyk zamiast komunikacji intencjonalnej.	- Tablice wyboru i skrypty dialogowe AAC. - Unikanie metafor, sarkazmu i dwuznaczności w komunikatach personelu. - Trening komunikacji funkcjonalnej (FCT: „chcę przerwać”, „nie rozumiem”). - Indywidualna terapia logopedyczna/neurologopedyczna (2x w tyg.).
Poruszanie się i motoryka d4	Motoryka duża prawidłowa (bieganie, wspinanie). Obniżona precyzja motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i planowania motorycznego (dyspraksja); nieprawidłowy chwyt pisarski i narzędzi.	- Dostosowanie przyborów (nakładki ergonomiczne na ołówki, nożyczki sprężynowe). - Indywidualne ćwiczenia rewalidacyjne ukierunkowane na motorykę małą i dużą. - Ćwiczenia integracji sensorycznej (SI).
Dbanie o siebie i samoobsługa d5	Samoobsługa zaburzona przez silne reakcje nadwrażliwości na bodźce dotykowe (ubrania, mokre ręce) i zapachowe; wybiórczość pokarmowa; trudność z odzieżą o skomplikowanych zapięciach.	- Stała kolejność czynności toaletowych wsparta paskiem wizualnym. - Stopniowe oswajanie faktur i zapachów w bezpiecznych warunkach. - Odzież bez trudnych zapięć; nadzór dorosłego przy posiłkach.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

6 ANALIZA JAKOŚCIOWA OBSZARÓW OBSERWACJI ORAZ ZALECENIA DO IPE · CD.

DOMENA ICF	OPIS FUNKCJONOWANIA I BARIERY	ZALECENIA DO IPE (METODY / DOSTOSOWANIA)
Życie domowe / Obowiązki placówki d6	Wykonuje obowiązki grupowe (sprzątanie kąpka zabaw, dyżury) po bezpośrednim przypomnieniu. Trudność w samodzielnym inicjowaniu czynności i doprowadzaniu ich do końca.	• Lista zadań na rzepy z odhaczaniem wykonanych czynności. • Stałe dyżury z modelowaniem przez dorosłego. • Wzmocnienia pozytywne (pochwała opisowa, system żetonowy).
Relacje i kontakty międzyludzkie d7	Trudności w inicjowaniu i podtrzymywaniu zabawy naprzemiennej. Brak umiejętności rozpoznawania sygnałów niewerbalnych wysyłanych przez rówieśników. Częste nieporozumienia prowadzące do zachowań oporowych.	• Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w małej grupie. • Historyjki Społeczne (Social Stories) modelujące zachowania prospołeczne. • Asystowanie w zabawach grupowych na zasadzie rówieśnika-mentora. • Jasne, wizualne zasady panujące w klasie/grupie.
Główne dziedziny życia (Edukacja) d8	Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych wymaga dostosowania metod, tempa i form pracy oraz stałego nadzoru nauczyciela. Szybka męczliwość przy zadaniach pisemnych i instrukcjach wieloetapowych.	• Dostosowane karty pracy (mniej bodźców, większa czcionka, jedno polecenie na raz). • Wsparcie nauczyciela współorganizującego / asystenta w zadaniach kierowanych. • Przerwy sensoryczne wpisane w plan zajęć.
Życie społecznościowe i obywatelskie d9	Trudność w uczestnictwie w apelach, uroczystościach i wyjściach zbiorowych z powodu przeciążenia sensorycznego i tłumy – wycofanie lub zachowania trudne.	• Wcześniejsze przygotowanie (historyjka społeczna, zdjęcia miejsca, plan wydarzenia). • Słuchawki wygłaszające i miejsce z możliwością wyjścia. • Stopniowe wydłużanie czasu udziału w wydarzeniach grupowych.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

7 WYNIKI OBSERWACJI POGŁĘBIONEJ (NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE)

Arkusz Obserwacji Behawioralnej ABC

Zidentyfikowano **14 epizodów** zachowań trudnych. **Bodźce wyzwajające (A)**: trudne polecenia pisemne, hałas, niespodziewane przejścia między aktywnościami. **Topografia zachowania (B)**: głośny krzyk, odmowa zejścia z dywanu, odpychanie kart pracy. **Funkcja (C)**: ucieczka przed przeciążeniem sensorycznym / zadaniem trudnym poznawczo.

Zalecenie: protokół wyprzedzający i nauka komunikatu zastępczego.

Profil Sensoryczny (Kwestionariusz Przetwarzania)

Reaktywność mieszana. **Układ słuchowy** – silna nadwrażliwość na nagłe dźwięki i gwar korytarza (zalecane słuchawki); **układ dotykowy** – obronność dotykowa na faktury klejące i mokre; **układ proprioceptywny i przedsionkowy** – poszukiwanie stymulacji dociskowej i ruchowej (huśtanie, kołysanie się).

Profil Biopsychospołeczny

Uwarunkowania biologiczne: spektrum autyzmu, zaburzenia snu wpływają na zmęczenie poranne. **Uwarunkowania psychologiczne**: silny lęk przed zmianą schematu, sztywność poznawcza. **Czynniki środowiskowe**: wysokie zaangażowanie rodziny, pozytywna reakcja na stałą kadrę.

Arkusz Oceny Rozwoju Mowy i Komunikacji

Zasób słownika biernego w normie wiekowej; wąski zasób czynny w sytuacjach swobodnych. Występują **echolalie natychmiastowe** i trudności pragmatyczne (brak intonacji, trudność w podtrzymaniu dialogu).

Zalecenie: schematy dialogowe i piktogramy wspierające.

Arkusz Poziomu Rozwoju Teorii Umysłu (ToM)

Poziom rozwoju ToM **poniżej normy wiekowej**. Trudność w zadaniach z fałszywym przekonaniem (False Belief Task) oraz w rozpoznawaniu perspektywy i intencji innych osób. Trudności te generują konflikty rówieśnicze przez błędną interpretację zachowań kolegów.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

8 INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W CELU POPRAWY FUNKCJONOWANIA

§ 7 ust. 6 pkt 6.

RODZAJ WSPARCIA	ZAKRES WDROŻONYCH DZIAŁAŃ I METODY	EFEKTYWNOŚĆ I OBSERWOWANE ZMIANY
Dostosowania środowiskowe i dydaktyczne	Wyznaczenie strefy wyciszenia w sali; zredukowanie bodźców wzrokowych na tablicach ściennych; zastosowanie słuchawek wygłuszających podczas pracy stolikowej; wprowadzenie indywidualnego planu dnia na rzepy.	Spadek liczby epizodów trudnych zachowań o ok. 40%; wydłużenie czasu skupienia na pojedynczym zadaniu z 3 do 8 minut.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacja	Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (TUS – 1x w tyg.); indywidualne zajęcia logopedyczne (1x w tyg.); ćwiczenia integracji sensorycznej (SI) na sali gimnastycznej.	Lepsze tolerowanie obecności innych dzieci w trakcie zajęć kierowanych; pierwsze próby proszenia o przerwę za pomocą gestu/piktogramu.
Współpraca z domem rodzinnym	Cotygodniowe konsultacje z rodzicami; zeszyt korespondencji dom-placówka; ujednolicenie systemu komunikatów i nagród behawioralnych.	Wysoka spójność w reakcjach dorosłych na zachowania trudne; wzrost poczucia bezpieczeństwa u dziecka.

Informacja dla rodzica. Niniejszy raport stanowi opinię placówki o funkcjonowaniu dziecka i jest przekazywany rodzicowi oraz zespołowi orzekającemu poradni. Wyniki obserwacji służą zaplanowaniu wsparcia, a nie ocenie dziecka. Zachęcamy do rozmowy z Zespołem o każdej części dokumentu.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

9 ZALECENIA Z PORADNI I SPOSOBY ICH REALIZACJI W PLACÓWCE

Zalecenia zawarte w **orzeczeniu / opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej** nr [Numer] z dnia [Data] oraz przyjęte przez Zespół sposoby ich realizacji. Zajęcia przydzielone dziecku/ucniowi zestawiono w podziale na **rewalidację** (kształcenie specjalne) i **pomoc psychologiczno-pedagogiczną**:

A · ZAJĘCIA REWALIDACYJNE · RAZEM

2 godz. = 120 min / tydz. · 3 rodzaje zajęć

B · POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA · RAZEM

3 godz. 30 min = 210 min / tydz. · 5 form pomocy**A Zajęcia rewalidacyjne przydzielone dziecku / uczniowi** · kształcenie specjalne · na podstawie orzeczenia

RODZAJ ZAJĘĆ	ZAKRES / CEL	PROWADZĄCY	FORMA	WYMIAR TYG.
Rewalidacja: rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i wdrażanie AAC	tablice wyboru, skrypty dialogowe, trening komunikacji funkcjonalnej (FCT)	Pedagog specjalny / neurologopeda	indywidualnie	1 × 60 min 60 min / tydz.
Rewalidacja: trening umiejętności społecznych i teorii umysłu (ToM)	rozpoznawanie emocji i intencji, historyjki społeczne, naprzemiennosc	Pedagog specjalny	indywidualnie / w parze	1 × 30 min 30 min / tydz.
Rewalidacja: usprawnianie motoryki małej i grafomotoryki	chwyt pisarski, koordynacja wzrokowo-ruchowa, planowanie ruchu	Terapeuta pedagogiczny	indywidualnie	1 × 30 min 30 min / tydz.
Razem zajęcia rewalidacyjne				2 godz. 120 min / tydz.

B Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej · rodzaj, forma i wymiar czasowy

RODZAJ ZAJĘĆ	ZAKRES / CEL	PROWADZĄCY	FORMA	WYMIAR TYG.
Zajęcia logopedyczne	artykulacja, pragmatyka wypowiedzi, redukcja echolalii, dialog	Logopeda	indywidualnie	1 × 45 min 45 min / tydz.
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (TUS)	naprzemiennosc, radzenie sobie z przegraną, odczytywanie sygnałów rówieśników	Psycholog	grupa 3–5 osób	1 × 45 min 45 min / tydz.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	uwaga, pamięć, uogólnianie wiedzy, organizacja pracy	Terapeuta pedagogiczny	grupa do 5 osób	1 × 45 min 45 min / tydz.
Zajęcia specjalistyczne: integracja sensoryczna (SI)	modulacja sensoryczna, dieta sensoryczna, przerwy sensoryczne	Terapeuta SI	indywidualnie	1 × 45 min 45 min / tydz.
Porady i konsultacje dla rodziców	ujednoczenie oddziaływań dom–placówka, zeszyt korespondencji	Psycholog / koordynator	rodzice	1 × 30 min 30 min / tydz.
Razem pomoc psychologiczno-pedagogiczna				3 godz. 30 min 210 min / tydz.

Uwaga: godzina rewalidacji = 60 min; godzina zajęć PPP = 45 min (w przedszkolu czas dostosowany do możliwości dziecka).

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

C Pozostałe zalecenia poradni i sposoby ich realizacji w placówce

LP.	ZALECENIE PORADNI (Z ORZECZENIA / OPINII)	SPOSÓB REALIZACJI W PLACÓWCE	REALIZATOR / WYMIAR	STATUS
1	Wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie	Obecność w czasie zajęć kierowanych i przejść między aktywnościami; pomoc w dekodowaniu poleceń.	Nauczyciel współorganizujący · wg arkusza organizacji	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane
2	Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz form i metod pracy	Karty pracy z jednym poleceniem, większa czcionka, ograniczenie bodźców; wydłużony czas; ocenianie wysiłku i postępu.	Wychowawca i nauczyciele · na bieżąco	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane
3	Zapewnienie stałości, przewidywalności i struktury otoczenia	Wizualny plan dnia; zapowiadanie zmian; stały skład kadry; protokół wyprzedzający przed wydarzeniami grupowymi; strefa wyciszenia i słuchawki.	Wychowawca · codziennie	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane
4	Ścisła współpraca z rodzicami i ujednolicenie oddziaływań	Cotygodniowe konsultacje; wspólny system komunikatów i wzmocnień; udział rodziców w ewaluacji IPET.	Koordinator zespołu · 1 x / tydz.	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane

Koordinator Zespołu
podpis i data

Dyrektor placówki
podpis i data

Specjalista
podpis i data

Rodzic / opiekun prawny – zapoznałam/em się z raportem
podpis i data